

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : فاطمه احمد محمد خليل

المحافظة : القاهرة

الحي / المدينة : الزيتون

العنوان : --

رقم البطاقة : 28108190101909 رقم التليفون : 01004042513

تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 19-08-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تاموكسيفين علاج هرموني [14160] **قسم العلاج :** الاورام

----- التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقع:

التوقع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناقشة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطـة العـلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فاطمه احمد محمد خليا National ID: 28108190101909	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Tamoxifen hormonal therapy.
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

فاطمة
احمد محمد خليل
٣٩ سن عبدالله فريد
الزيتون - القاهرة

١٩٨١/٠٨/٢٩

٢٨١.٠٨١٩.٠١.١٩.٠٩

LG7202150

٢.٢٥/٠٧ ٢٨١.٠٨١٩.٠١.١٩.٠٩

ربة منزل

أنفى
عمرو عبدالغنى جيسس
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

٢٠٢٢/٠٧/٢٥



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مختصة

04/15/2026

MDT FORM

Name:	Fatma Mohamoud Mohamoud * \	MRN:	6729
Age:	45 Y	ID:	28108190101909
Menopausal Sta	E2 level >> R	Phone:	01023057454
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	HTN	Reason Of MDT:	to shift to AJ

Clinical Data:

BX: IDC GII
ER: 7/8 PR: 6/8 HER2: +3 KI67:

R

L

Sonomammography:

Mets Workup:

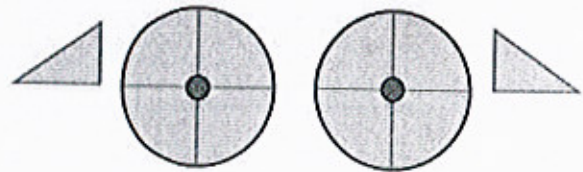
History:

female Pt IDC cT4b N1 ER 7/8 PR 6/8 her 2 +3 >>> received TCHP *6 >>>
It MRM >> PCR >>> didnot receive PORT >>received HP up to 1 year >> on
tam 3 years ago for MDT to shift to AJ
E2 level >> R

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

as per last mdt 3/3 continue TAM 5 yrs then shift to AJ as regards zoladex
continue based on the result of E2 FSH LH



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ محمد كبري د/ناني حسن					

Name: فاطمة احمد محمد		
MR. : 6729		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه female Pt IDC cT4b N1 ER 7/8 PR 6/8 her 2 +3 >>> received TCHP *6 >>> It MRM >> PCR >>> didnt receive PORT >> on tam 3 years ago for MDT to shift to AI today for tam , supp ttt for 3 mn 4/2026 mdt : continue TAM 5 yrs then shift to AI as regards zoladex continue based on the result of E2 FSH LH sm ,,,req tamoxifen +supportive*3m cilinc visit :30/9/2026		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim الطبيب المعالج :	
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / فاطمة احمد محمد
Patient No. : 28108190101909
Specimen No. : SR-824/23
Sex : Female
Age : 41 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003483
Request Date : 27/07/2023
Verification Date : 16/08/2023
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross Examination:
Two paraffin block labeled by (203072/23) and designated as (RT & LT) & four slides were received.

Microscopic Examination:
Examination of Right breast mass:
Topathological examination revealed a cores of breast tissue showing diffuse stromal oedema and focal adenosis. Some of the proliferating ducts are irregularly dilated. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells. No atypia or malignancy in sections examined.

Examination of Left breast mass:
Histological type: Invasive duct carcinoma.
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1)
T: 1: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (Allred score 7/8).
2: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 6/8).
3: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:
Bilateral breast masses, Slide revision:
Right breast mass:
Focal adenosis. No malignancy.
Left breast mass:
Invasive duct carcinoma, Grade II.

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 16/08/2023 11:10:23

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

ent Name : الاستاذة / فاطمه احمد محمد
ent No. : 28108190101909
No. : SR-824/23
: Female
: 41 Y
arreing Doc :

Request No. : 13003483
Request Date : 27/07/2023
Verification Date : 16/08/2023
Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

R: Positive (score 7/8).
R: Positive (score 6/8).
er2: Positive (score 3+).

Marwa Mahmoud

Dr. Rana Fathy

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 16/08/2023 11:10:23

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed you

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**
Compared to 26/07/2023

1. Chest:

- Stable left breast mild diffuse skin thickening with lower central irregular densities.
- Regression of the left axillary level I and II prominent lymph nodes the largest measures 1.8 x 0.9 cm compared to 1.6 x 2.7 cm.
- No sizable pulmonary nodules, no masses or consolidations.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or biliary radicles dilatation on non-contrast basis.
- Patent main portal vein and its branches.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.